

家庭医生安然 · 健康知识库（演示用）

适用角色：家庭医生/健康顾问「安然」

声明：本文件仅供科普与就医引导演示，不能替代执业医师面诊、检查、诊断或处方。出现紧急情况请立即拨打急救电话或前往急诊。

一、使用说明（给 AI 检索）

当用户描述不适时，优先匹配本知识库中的「常见场景」「红旗症状」「居家观察」「何时就医」段落，用通俗语言回答，并强调信息不足时不要下定论。

回答应避免开具具体处方药剂量；可提示“需由医生评估后用药”。

二、问诊信息收集清单

建议引导用户补充：1）主要症状与部位；2）开始时间与变化；3）诱因（受凉、饮食、劳累、外伤等）；4）伴随症状（发热、呕吐、胸闷、皮疹等）；5）基础病与过敏史；6）正在服用的药物；7）怀孕/备孕/哺乳情况；8）近期旅行或传染病接触史。

三、紧急红旗症状（优先急诊）

3.1 循环与呼吸

突发严重胸痛/压榨感并向左臂、下颌放射；呼吸困难、口唇发紫；大咯血；晕厥或意识不清；一侧肢体无力、口角歪斜、言语困难（疑似中风）。

3.2 出血与外伤

无法止住的大出血；头部外伤后剧烈头痛、反复呕吐、嗜睡；严重烧伤；可疑骨折伴肢体畸形或远端苍白冰凉。

3.3 过敏与感染

全身风团伴喉头紧、喘鸣；高热伴颈强直、皮疹、精神萎靡；婴儿拒食、持续高热、抽搐。

3.4 精神心理危急

明确自杀/自伤计划或正在实施；严重幻觉妄想导致危险行为。应建议立即寻求紧急专业帮助。

四、常见场景科普

4.1 普通感冒与流感样症状

常见表现：鼻塞流涕、咽痛、轻中度咳嗽、低热或中热、乏力。多数为自限性，休息、补水、对症处理为主。

居家观察：体温变化、饮水与尿量、呼吸是否顺畅、是否出现胸痛或血痰。

建议就医：高热超过3天不退；呼吸急促；原有慢阻肺/哮喘明显加重；老人、婴幼儿、孕妇症状进展快。

4.2 急性肠胃炎样不适

常见表现：恶心呕吐、腹痛、腹泻，可能与不洁饮食有关。重点是防脱水。

居家建议：少量多次补液；清淡饮食；观察尿量与精神状态。

建议就医：持续剧烈腹痛；便血/黑便；高热；明显脱水（口干、尿少、头晕）；孕妇或慢性病患者症状重。

4.3 头痛

紧张性头痛常见于压力与睡眠不足；偏头痛可有搏动性疼痛、畏光畏声。突然“一生中最剧烈”的头痛需警惕急症。

建议就医：突发爆炸样头痛；头痛伴发热颈强直；头痛伴神经功能缺损；头部外伤后进行性加重。

4.4 失眠与节律紊乱

睡眠卫生：固定起床时间、午后少咖啡因、睡前减少屏幕刺激、卧室偏暗偏凉、白天适度运动。

短期失眠可先调整作息与压力源；长期失眠、白天功能受损或伴情绪低落，建议线下评估，不自行长期依赖镇静催眠药。

4.5 焦虑相关躯体化

可表现为心慌、胸闷、出汗、胃肠不适。需先排除急症心脏/肺部问题的红旗症状。

缓解思路：规律作息、呼吸放松、减少咖啡因、适度运动；持续影响生活时建议心理/精神科评估。

4.6 血压与代谢管理（科普）

高血压管理强调：限盐、控体重、规律运动、戒烟限酒、遵医嘱用药与监测，不因“感觉没事”自行停药。

血糖管理强调：饮食结构、运动、体重、足部与视力随访；低血糖要会识别（出汗、心慌、手抖、意识改变）。

五、居家护理通用原则

- 1) 先安全：有红旗症状先急诊，不要硬扛。
- 2) 先观察：记录体温、症状时间线、诱因与缓解因素，方便就医描述。
- 3) 先基础：睡眠、水分、营养、适度活动往往比“到处找偏方”更重要。
- 4) 用药谨慎：不随意合用多种感冒药；不把抗生素当万能药；儿童与孕妇用药必须更谨慎。

5) 传染病防护：发热呼吸道症状期间减少聚集，戴口罩，勤洗手。

六、就医沟通话术模板

建议用户按以下结构向医生说明：

“我主要是……（症状），从……开始，加重/缓解情况是……；伴随……；既往有……；对……过敏；正在服用……；我最担心的是……。”

七、角色回答示例边界

正确：根据描述给出可能方向与观察建议，并列出现何时就医。

错误：直接说“你就是某病”、给出具体处方剂量、或鼓励延误急诊。

信息不足时模板：目前信息还不够判断，建议补充……；若出现……请马上就医。

八、关键词索引（便于检索）

急诊红旗；胸痛；呼吸困难；中风；过敏性休克；高热；脱水；感冒；流感；腹泻；头痛；失眠；焦虑；高血压；血糖；孕妇；婴幼儿；老人；用药安全；就医话术。